

# **Protocolo de Acesso e Critérios de Regulação de Consulta em Psiquiatria nos Distritos Sanitários**

**SECRETÁRIO DA SAÚDE**

Jean Rodrigues da Silva

**DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Simone Aparecida de Souza

**DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE**

Andrei Popovski Kolaceke

**DIRETORIA TÉCNICA**

Niso Eduardo Balsini

**GERÊNCIA DE DISTRITO SANITÁRIO**

Heloísa Hoffmann – Distrito Centro

Luiza Helena Cardoso dos Santos – Distrito Norte

Jaqueline Fornari – Distrito Sul

**GERÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ARTICULAÇÃO DA REDE EM SAÚDE**

Anna Paula Pinheiro

**GERÊNCIA DE REGULAÇÃO E AUDITORIA**

Akadenilques de Oliveira Martins Souza Kudla

**GERÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS**

Flavia Schwinden Muller

**COORDENAÇÃO DO NÚCLO DE APOIO À REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE**

Fabiana Bussolaro Pereira

**ELABORAÇÃO**

Matha Maria Vieira de Salles Abreu Artilheiro – Médica de Família e Comunidade

Vivianne Samara Conzatti – Psicóloga

**COLABORADORES**

Luci Leia Honorato de Carvalho – Psicóloga

Marco Aurélio Engel – Médico Psiquiatra

Marlon Willfried Fritze Soares – Médico Psiquiatra

Rodolfo Kras Amoretti – Médico Psiquiatra

Rubia Harmel – Psicóloga

Silvia Marchesan de Pra Nornberg – Médico Psiquiatra

**SUMÁRIO**

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 – APRESENTAÇÃO.....</b>                                                | <b>04</b> |
| <b>2 – ACESSO AO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO.....</b>                          | <b>05</b> |
| <b>3 – CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....</b>                                  | <b>06</b> |
| 3.1 – Psiquiatria Adulto.....                                               | 06        |
| 3.2 – Psiquiatria Infantil .....                                            | 06        |
| <b>4 – CLASSIFICAÇÃO DE PRIORIDADE PARA ATENDIMENTO NA PSIQUIATRIA.....</b> | <b>07</b> |
| 4.1 – Prioridade P1 para Psiquiatria Adulto.....                            | 07        |
| 4.2 – Prioridade P1 para Psiquiatria Infantil.....                          | 07        |
| 4.3 – Prioridade P2 para Psiquiatria Adulto.....                            | 08        |
| 4.4 – Prioridade P2 para Psiquiatria Infantil.....                          | 08        |
| 4.5 – Prioridade P3 para Psiquiatria Adulto e Infantil.....                 | 08        |
| <b>5 – REFERÊNCIAS.....</b>                                                 | <b>09</b> |

## **1 – APRESENTAÇÃO**

A crescente demanda em saúde mental, principalmente nos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS), faz parte do processo de redirecionamento do modelo assistencial à pessoa em sofrimento mental, que teve como marco constitucional a Lei Federal nº 10.216, de 06 de abril de 2001, acompanhada de ações dos grupos da “Reforma Psiquiátrica” e do “Movimento Antimanicomial” no Brasil.

Estudos mostram que aproximadamente 10% da população apresenta queixas que geram, na APS, algum tipo de intervenção por profissionais da saúde.

Estima-se que, em um ano, cerca de um milhão e meio de habitantes de Santa Catarina venha a se queixar, em algum momento, de sintomas relacionados a alguma categoria de transtorno psiquiátrico. Boa parte deles levará estas queixas às equipes de Saúde, seja na APS ou em unidades de Pronto Atendimento.

Diante deste cenário, faz-se necessário ampliar as estratégias de atendimento e apoio à equipe de Medicina da Família e Comunidade. Com isto, a teleconsultoria e as ações de matriciamento são componentes essenciais neste processo. Ambos visam esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho, com respostas baseadas em evidências científicas e adequadas às características territoriais.

Considerando a demanda evidenciada, estabelecem-se novas estratégias de atuação para o atendimento da Psiquiatria nos Distritos Sanitários e este Protocolo tem como objetivo especificar os critérios de elegibilidade e priorização para atendimento e orientar sobre o acesso através da Central de Regulação.

## **2 – ACESSO AO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO**

O atendimento psiquiátrico no Distrito é um recurso da Rede de Atenção Psicossocial, destinado aos usuários que residem no município de Joinville.

O acesso será realizado via Sistema Integrado de Gestão (SIG) - SaudeTech e regulado através da Central de Regulação. O encaminhamento deve ser feito pela equipe médica das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) com a realização da Teleconsultoria Compulsória em Psiquiatria e possui os seguintes critérios:

- O objetivo do atendimento deve, preferencialmente, visar o acompanhamento clínico de tratamento para usuários;
- Os usuários encaminhados devem, preferencialmente, já ter iniciado o acompanhamento prévio de 60 dias com a equipe médica e/ou multidisciplinar da UBSF e sem melhora ou progresso;
- No acompanhamento prévio, deve-se descartar comorbidades clínicas, adequação das medicações, reações adversas e causas orgânicas;
- O médico clínico ter realizado a orientação breve e pontual com o Teleconsultor Psiquiatra através do sistema de comunicação pactuado;
- Solicitar a Teleconsultoria Compulsória em Psiquiatria – o Psiquiatra regulador aprovará a inclusão do usuário na fila de consulta com a especialidade.

### 3 – CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

São elegíveis para atendimento psiquiátrico os seguintes casos:

#### 3.1 – Psiquiatria Adulto

São atendidos pela Psiquiatria Adulto, os usuários com idade superior à 15 anos.

- Usuários que apresentem sofrimento psíquico moderado e não estabilizado (*porém sem risco imediato ou ideação suicida ou episódios de auto ou heteroagressão*<sup>1</sup>) que não apresentem resposta positiva ao tratamento mesmo estando em acompanhamento com equipe multiprofissional da UBSF;
- Agravamento ou alterações moderadas do estado mental (euforia, agitação, paranoia, alucinações);
- Quadro psicótico agudo, sem sinais de agitação psicomotora e/ou episódios de auto ou heteroagressão, com apoio sociofamiliar que possibilite tratamento extra-hospitalar;
- Episódios depressivos e/ou ansiosos moderados (*porém sem risco imediato ou ideação suicida ou episódios de auto ou heteroagressão*);
- Episódios moderados decorrentes do uso nocivo/abusivo de álcool ou outras substâncias psicoativas que gerem prejuízos à saúde e convivência sociofamiliar.

#### 3.2 – Psiquiatria Infantil

São atendidos pela Psiquiatria Infantil, os usuários com idade entre 0 e 14 anos, 11 meses e 29 dias. Todos os critérios abaixo requerem acompanhamento prévio de 60 dias na UBSF.

- Mudança no padrão habitual de comportamento ou surgimento de comportamentos atípicos para a fase de desenvolvimento que prejudiquem convivência familiar e social e/ou desempenho escolar<sup>2</sup>;
- Comportamento automutilador e discurso frequente sobre morte (*porém sem risco imediato, ideação ou planejamento suicida*);
- Alterações de conduta: auto e heteroagressão; impulsividade e dificuldade de controle emocional; reações explosivas desproporcionais;
- Dificuldade de relacionamento e ajuste social: podendo se manifestar com pares e/ou indivíduos mais velhos, comportamento retraído, inseguro ou ansioso no contato

---

1 Nos casos de risco imediato, ideação suicida ou episódios de auto ou heteroagressão o usuário deverá ser encaminhado para acolhimento nos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de referência ou atendimento Hospitalar – conforme gravidade ou território.

2 Englobam essas mudanças: alterações do sono ou apetite; enurese ou encoprese diurna ou noturna; manias e rituais; apego afetivo ou insegurança atípicos

social; padrão opositor e/ou dificuldade de aceitação e entendimento de regras sociais; comportamento impulsivo e agressivo no contato social;

- Presença de sintomas psicóticos: maus tratos a animais, alucinações, delírios ou padrão paranoide<sup>3</sup>.

#### **4 – CLASSIFICAÇÃO DE PRIORIDADE PARA ATENDIMENTO NA PSIQUIATRIA**

Os critérios de priorização respeitarão as determinações expressas no Art. 8º da Portaria nº 252/2021/SMS que regulamenta a gestão e a administração das filas de espera de consultas especializadas, exames, cirurgias e demais procedimentos, bem como o funcionamento da Central Macrorregional de Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde em Joinville.

##### **4.1 – Prioridade P1 para Psiquiatria adulto**

- Usuários que apresentem sofrimento psíquico moderado e não estabilizado (*porém sem risco imediato ou ideação suicida ou episódios de auto ou heteroagressão*<sup>4</sup>) que não apresentem resposta positiva ao tratamento mesmo estando em acompanhamento com equipe multiprofissional da UBSF;
- Agravamento ou alterações moderadas do estado mental (euforia, agitação, paranoia, alucinações);
- Quadro psicótico agudo, sem sinais de agitação psicomotora e/ou episódios de auto ou heteroagressão, com apoio sociofamiliar que possibilite tratamento extra-hospitalar.

##### **4.2 – Prioridade P1 para Psiquiatria Infantil**

- Comportamento automutilador e discurso frequente sobre morte (*porém sem risco imediato, ideação ou planejamento suicida*);
- Alterações de conduta: auto e heteroagressão; impulsividade e dificuldade de controle emocional; reações explosivas desproporcionais;
- Presença de sintomas psicóticos: maus tratos a animais, alucinações, delírios ou padrão paranoide<sup>5</sup>.

---

3 Nos casos com episódios agudos que ofereçam risco de suicídio ou atentem contra a integridade e segurança de terceiros o usuário deverá ser encaminhado para o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil ou atendimento Hospitalar – conforme a gravidade.

4 Nos casos de risco imediato, ideação suicida ou episódios de auto ou heteroagressão o usuário deverá ser encaminhado para acolhimento nos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de referência ou atendimento Hospitalar – conforme gravidade ou território.

5 Nos casos com episódios agudos que ofereçam risco de suicídio ou atentem contra a integridade e segurança de terceiros o usuário deverá ser encaminhado para o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil ou atendimento Hospitalar – conforme a gravidade.

**4.3 – Prioridade P2 para Psiquiatria Adulto**

- Episódios depressivos e/ou ansiosos moderados (*porém sem risco imediato ou ideação suicida ou episódios de auto ou heteroagressão*);
- Episódios moderados decorrentes do uso nocivo/abusivo de álcool ou outras substâncias psicoativas que gerem prejuízos à saúde e convivência sociofamiliar;

**4.4 – Prioridade P2 para Psiquiatria Infantil**

- Mudança no padrão habitual de comportamento ou surgimento de comportamentos atípicos para a fase de desenvolvimento que prejudiquem convivência familiar e social e/ou desempenho escolar<sup>6</sup>;
- Dificuldade de relacionamento e ajuste social: podendo se manifestar com pares e/ou indivíduos mais velhos; comportamento retraído, inseguro ou ansioso no contato social; padrão opositor e/ou dificuldade de aceitação e entendimento de regras sociais; comportamento impulsivo e agressivo no contato social.

**4.5 – Prioridade P3 para Psiquiatria Adulto e Infantil**

Não haverá P3 para Psiquiatria Adulto e Infantil, o manejo de casos não elegíveis nos critérios P1 e P2 deverá ser feito na UBSF podendo contar com apoio de matriciamento com os Psiquiatras de referência de cada distrito ou outros componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

---

<sup>6</sup> Englobam essas mudanças: alterações do sono ou apetite; enurese ou encoprese diurna ou noturna; manias e rituais; apego afetivo ou insegurança atípicos



## 5 – REFERÊNCIAS

1. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. **Portaria SEI – SES.GAB/SES.UAP nº 252/2021/SMS**. Regulamenta a gestão e a administração das filas de espera de consultas especializadas, exames, cirurgias e demais procedimentos, bem como o funcionamento da Central Macrorregional de Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde em Joinville. Joinville – SC: 2021.
2. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. **Portaria SEI – SES.GAB/SES.UAP/SES.UAP.APA nº 204/2020/SMS**. Institui a "Linha de Cuidado da Saúde Mental". Joinville – SC: 2020.